

RTUP — Resección Transuretral de la Próstata

Información para el paciente · La cirugía estándar de larga trayectoria para el agrandamiento de la próstata **WARWIKI**

La RTUP es una cirugía común y muy comprobada para el agrandamiento de la próstata (HPB) que bloquea el flujo de orina. A través de un endoscopio que sube por la uretra — **sin incisión externa** — el cirujano recorta el tejido interno de la próstata que aprieta el canal urinario. Da una mejoría fuerte y duradera del flujo y tiene décadas de experiencia.

Acerca de este procedimiento

Se pasa un instrumento delgado (un **resectoscopio**) por la uretra. Con un pequeño asa eléctrica, el cirujano retira pieza por pieza el tejido interno que obstruye, ensanchando el canal. La parte externa de la próstata se deja en su lugar. Después se coloca una sonda mientras la zona sana.

¿Es segura?

La RTUP es una de las operaciones urológicas más estudiadas y muy eficaz. Como toda cirugía tiene riesgos — sangrado, infección, irritación temporal — y algunos efectos duraderos esperables (abajo). Funciona mejor en próstatas de **tamaño moderado**; las glándulas muy grandes pueden ir mejor con HoLEP, Aquablation o prostatectomía simple.

APRENDA LOS TÉRMINOS

RTUP

Resección transuretral de la próstata — cirugía con endoscopio para la HPB.

HPB

Agrandamiento benigno (no canceroso) de la próstata.

Resectoscopio

El instrumento de endoscopio y asa usado para recortar la próstata.

Eyacuación retrógrada

El semen va hacia atrás a la vejiga — un efecto común e inofensivo.

Sonda

Un tubo que drena la vejiga 1–3 días después.

Irrigación vesical

Enjuague suave por la sonda para limpiar sangre al inicio.

¿QUÉ CAMBIA DESPUÉS? La mayoría de los hombres logran un chorro mucho más fuerte. El cambio duradero más común es la **eyaculación retrógrada** — el semen va hacia atrás a la vejiga, así que el orgasmo se siente normal pero con poco o nada de líquido. Es inofensivo (aunque afecta la fertilidad). Los efectos graves en la erección o el control de orina son poco comunes.

Cómo prepararse

- Se hace con **anestesia raquídea o general** — siga las instrucciones de ayuno y medicinas (suspenda los anticoagulantes según le indiquen).
- Un **análisis de orina** para descartar infección primero.
- Organice quién lo lleve; planee una sonda por unos días.

Qué sucede y después

- 1 Está dormido o adormecido; se dan antibióticos.
- 2 El tejido prostático que obstruye se recorta por el endoscopio.
- 3 Se coloca una sonda, a veces con enjuague suave de la vejiga el primer día.
- 4 Suele ser una noche en el hospital; la sonda sale en **1–3 días**.

Espere **orina con sangre** y algo de ardor o urgencia un par de semanas; tome líquidos y evite hacer fuerza y levantar peso.

Llame a su equipo o busque atención si tiene:

- **No puede orinar** tras retirar la sonda
- **Sangrado abundante o coágulos** que bloquean el flujo
- Fiebre o escalofríos
- Sangrado que empeora (un sangrado leve hacia 1–2 semanas es común — descanso y líquidos)

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La RTUP retira la próstata interna que obstruye por endoscopio (sin incisión) — el estándar de larga trayectoria y muy eficaz para la HPB moderada.
2. Espere un chorro más fuerte; el cambio duradero común es la eyaculación seca/retrógrada (inofensiva).
3. La orina con sangre y la irritación ceden en un par de semanas. Llame si no puede orinar, hay sangrado abundante o fiebre.